# INTRODUCTION À LA SANTÉ AU TRAVAIL

Cours de 6e année de médecine
Unité : Santé au travail et environnement (STE)

*Dr S. LEBOUABI*
Maitre-assistant en médecine du travail

**OBJECTIF DU COURS :** Comprendre le rôle de la santé au travail et savoir raisonner devant une situation professionnelle : poste → exposition → santé → compatibilité → prévention.

## Objectifs pédagogiques

À la fin de ce cours, l'étudiant doit pouvoir :

1. Définir le concept de la santé au travail.
2. Énumérer les principaux organismes chargés de la santé au travail.
3. Expliquer les principes et fondements de la législation et de la réglementation en santé et sécurité au travail.
4. Décrire l'organisation de la médecine du travail en Algérie.
5. Connaître le rôle du médecin du travail.

**LE FIL ROUGE À RETENIR :** Le médecin du travail ne raisonne jamais sur la maladie seule. Il confronte toujours l'état de santé aux tâches réelles et aux risques du poste.

## Carte mentale du cours

| COMPRENDRE | ORGANISER | SURVEILLER | AGIR SUR LE TERRAIN | PRÉVENIR | DÉCIDER AVEC PRUDENCE |
|---|---|---|---|---|---|

# PARTIE I — COMPRENDRE LA DISCIPLINE

Concepts, histoire, cadre réglementaire et responsabilité de l'employeur

## 1. Introduction

La santé au travail s'intéresse à la relation entre le travail et la santé. Le travail peut favoriser l'intégration sociale et le bien-être, mais il peut aussi exposer à des agents chimiques, physiques, biologiques, biomécaniques ou organisationnels susceptibles d'altérer la santé.

En Algérie, la médecine du travail est intégrée à la politique nationale de santé. La loi n° 88-07 lui attribue une mission « préventive essentiellement et curative accessoirement » [4]. Cette formule doit être connue car elle résume toute la philosophie de la discipline.

> **IDÉE CENTRALE :** La médecine du travail ne se résume pas à faire des visites médicales : elle relie la clinique au poste de travail et transforme cette analyse en prévention.

## 2. Concepts fondamentaux

### 2.1. Santé, travail, santé au travail

L'OMS définit la santé comme un état de bien-être physique, mental et social, et non comme la seule absence de maladie [1]. Appliquée au travail, cette conception conduit à prendre en compte les expositions, l'organisation, l'ergonomie, les relations professionnelles et la capacité à rester en emploi.

La santé au travail est donc un champ multidisciplinaire. La médecine du travail en est la composante médicale : elle apporte l'examen clinique, le raisonnement de causalité professionnelle, l'appréciation de la compatibilité santé–poste et le conseil médical [2].

> **À MÉMORISER :** Santé au travail = champ large. Médecine du travail = composante médicale spécialisée.

### 2.2. Danger, exposition, risque, dommage

| Notion | Question simple | Exemple |
|---|---|---|
| **Danger** | Qu'est-ce qui peut nuire ? | Bruit, benzène, machine non protégée. |
| **Exposition** | Qui est en contact, comment et combien de temps ? | Inhalation répétée de vapeurs. |
| **Risque** | Quelle probabilité de dommage dans ces conditions ? | Risque hématotoxique ou accidentel. |
| **Dommage** | Qu'est-il réellement survenu ? | Cytopénie, surdité, traumatisme. |

> **PIÈGE FRÉQUENT :** Un danger peut être présent sans que tous les travailleurs aient le même risque : le risque dépend des conditions réelles d'exposition.

### 2.3. Maladie professionnelle et maladie à caractère professionnel

La maladie professionnelle (MP) relève d'un système réglementaire de reconnaissance. La maladie à caractère professionnel (MCP) est une notion plus large : le médecin estime qu'un lien avec le travail est plausible, même si les conditions d'un tableau de MP ne sont pas établies. Cette distinction sera détaillée dans le cours consacré aux AT/MP [8].

## 3. Repères historiques

L'histoire de la médecine du travail suit deux évolutions parallèles : la connaissance scientifique des risques professionnels et la construction progressive d'un droit de protection des travailleurs. Bernardino Ramazzini est classiquement cité comme un pionnier de la discipline, notamment pour avoir systématisé la question du métier dans l'interrogatoire médical [23].

### 3.1. Quelques dates utiles en Algérie

**1956–1958 :** premiers textes et premières structures organisées de médecine du travail.
**1974 :** création de l'ONIMET, étape importante de structuration. [25]
**1988 :** loi n° 88-07 : texte cadre de l'hygiène, de la sécurité et de la médecine du travail [4].
**1993 :** décret exécutif n° 93-120 : organisation pratique de la médecine du travail [10].
**1995–2001 :** convention-type, travaux fortement exposés, documents médicaux et rapport annuel [12–14].
**2025 :** mise à jour majeure : nouvelles normes des services le 11 mars et nouveau rapport type le 20 mars [15,16].

## 4. Principes généraux de législation

La médecine du travail est une médecine réglementée. L'étudiant doit savoir distinguer le texte cadre, ses décrets d'application et les arrêtés techniques. La hiérarchie juridique explique pourquoi un support de cours ancien ne doit jamais primer sur un texte officiel actualisé.

**LES TEXTES À CONNAÎTRE EN PRIORITÉ :**
- Loi 88-07 = cadre général : L'hygiène, la sécurité et la médecine du travail
- Décret 93-120 = organisation de la médecine du travail
- Arrêté 11 mars 2025 = normes des services de santé du travail
- loi n° 83-13 pour les AT/MP
- loi n° 90-03 pour l'inspection du travail
- loi n° 18-11 pour le cadre sanitaire et le secret des informations médicales [5,7,8].

## 5. Responsabilité de l'organisme employeur

La médecine du travail est une obligation de l'organisme employeur et son financement est à sa charge [4]. Cela signifie que l'employeur doit organiser le dispositif, libérer les travailleurs pour les examens réglementaires et fournir au médecin les informations nécessaires sur les postes, produits et procédés.

Surtout, la surveillance médicale ne transfère jamais la responsabilité générale de prévention au médecin. La prévention technique et organisationnelle reste une responsabilité de l'employeur, avec les structures d'hygiène et de sécurité prévues par la réglementation [4,11].

**FORMULE D'EXAMEN :** Employeur = organise, finance et met en œuvre la prévention.
Médecin du travail = observe, surveille, conseille et alerte.

## 6. L'entreprise : terrain de l'action

Un intitulé de métier ne décrit jamais complètement le risque. Le médecin doit passer du poste administratif au travail réel. Deux salariés ayant la même profession peuvent avoir des expositions très différentes selon l'atelier, les outils, les produits, les horaires ou les tâches occasionnelles.

| POSTE | TÂCHES RÉELLES | DANGERS | EXPOSITIONS | EFFETS POSSIBLES |
|---|---|---|---|---|

### 6.1. Les secteurs d'activité économique

Les activités professionnelles sont traditionnellement réparties en trois grands secteurs économiques, selon la nature de l'activité principale exercée.

| Secteur | Activités principales | Exemples de risques professionnels |
|---|---|---|
| **Primaire** | Agriculture, élevage, pêche, exploitation forestière | Pesticides, risques biologiques, contraintes climatiques, accidents mécaniques |
| **Secondaire** | Industrie manufacturière, transformation des matières premières, bâtiment et travaux publics (BTP) | Bruit, poussières, produits chimiques, machines, manutention |
| **Tertiaire** | Commerce, transport, administration, enseignement, santé, services | Risques psychosociaux, TMS, risques routiers, risques biologiques selon l'activité |

**À RETENIR :** Le secteur d'activité oriente l'identification des risques professionnels, mais ne suffit pas à les déterminer. L'analyse des tâches réelles et des conditions d'exposition reste indispensable.

**EXEMPLE :** Un établissement hospitalier appartient au secteur tertiaire, mais ses travailleurs peuvent être exposés à des risques biologiques, chimiques, physiques, biomécaniques et psychosociaux.

### 6.2. Classification des entreprises selon leur taille

La taille d'une entreprise peut être appréciée notamment à partir de son effectif, de son chiffre d'affaires annuel et du total de son bilan.

En Algérie, la loi n° 17-02 du 10 janvier 2017 distingue les catégories suivantes [24] :

| Catégorie | Effectif de référence |
|---|---|
| **Très petite entreprise (TPE)** | 1 à 9 personnes |
| **Petite entreprise (PE)** | 10 à 49 personnes |
| **Moyenne entreprise (ME)** | 50 à 250 personnes |
| **Grande entreprise (GE)** | Hors catégorie PME ; plus de 250 personnes constitue un repère usuel, non une définition juridique autonome dans cette loi |

**PRÉCISION RÉGLEMENTAIRE :** La classification légale des PME ne repose pas uniquement sur l'effectif. Elle tient également compte du chiffre d'affaires ou du bilan annuel et du critère d'indépendance, conformément à la loi n° 17-02.

**INTÉRÊT EN MÉDECINE DU TRAVAIL :** La taille de l'entreprise influence notamment les moyens disponibles pour organiser la prévention, la complexité de la surveillance des travailleurs et la coordination des intervenants. Cependant, une petite entreprise peut présenter des risques professionnels aussi importants qu'une grande entreprise.

**À MÉMORISER : :** La taille de l'entreprise ne détermine pas, à elle seule, le niveau du risque professionnel ni les modalités réglementaires d'organisation de la médecine du travail.

### 6.3. Classification selon le statut de l'organisme employeur

Selon leur nature juridique et leur mode de propriété, on distingue notamment :

- **Organismes publics :** administrations, établissements publics et entreprises publiques.
- **Entreprises privées :** structures appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé.
- **Entreprises à capitaux mixtes :** structures associant des participations publiques et privées.

**À RETENIR :** Quelle que soit la nature de l'organisme employeur, la prévention doit être adaptée aux risques réels de l'activité professionnelle et aux dispositions légales et réglementaires applicables.

### 6.4. Principales familles de risques professionnels

Les risques professionnels résultent de l'exposition des travailleurs à différents dangers présents dans leur environnement et leurs conditions de travail.

| Famille de risques | Exemples d'exposition | Effets possibles sur la santé |
|---|---|---|
| **Physiques** | Bruit, vibrations, chaleur, rayonnements | Surdité, troubles vasculaires, lésions liées aux rayonnements |
| **Chimiques** | Solvants, poussières, fumées, gaz | Intoxications, dermatoses, atteintes respiratoires, cancers |
| **Biologiques** | Virus, bactéries, contact avec le sang | Infections professionnelles |
| **Biomécaniques et ergonomiques** | Manutention, gestes répétitifs, postures contraignantes | Troubles musculosquelettiques (TMS), lombalgies |
| **Psychosociaux et organisationnels** | Surcharge de travail, violences, horaires atypiques | Stress, troubles du sommeil, souffrance psychique |
| **Accidentels** | Machines dangereuses, chutes de hauteur, circulation d'engins | Plaies, fractures, traumatismes graves |

**À RETENIR :** Le danger ne suffit pas à déterminer le risque. L'évaluation doit tenir compte de l'intensité, de la durée, de la fréquence et des conditions réelles d'exposition, ainsi que de la gravité potentielle des dommages.

**RÉFLEXE DU MÉDECIN DU TRAVAIL :** Identifier les dangers → caractériser les expositions → rechercher les effets sanitaires → proposer la prévention adaptée.

## PARTIE II — ORGANISER ET AGIR

Acteurs, organisation, normes, missions et rôle du médecin du travail

## 7. Organisation de la santé au travail en Algérie

La santé au travail repose sur une chaîne d'acteurs complémentaires. Le médecin du travail n'agit ni seul ni à la place des autres intervenants.

- l'organisme employeur : responsable de l'organisation et de la prévention ;
- les travailleurs et leurs représentants : acteurs de terrain et partenaires de prévention ;
- les structures d'hygiène et de sécurité et la CPHS : analyse et prévention collective ;
- l'inspection du travail : contrôle de l'application de la législation ;
- la CNAS : assurance AT/MP et actions de prévention ;
- les structures sanitaires : soins, avis spécialisés et examens ;
- les organismes de prévention, notamment l'INPRP : appui technique et institutionnel [26].

**REPÈRE INSTITUTIONNEL :** OIT = Organisation internationale du Travail. BIT = Bureau international du Travail, secrétariat permanent de l'OIT. Ce ne sont pas deux organisations distinctes.

### 7.1. Articulation des acteurs de la santé au travail en Algérie

La santé au travail repose sur une organisation impliquant des acteurs internes à l'entreprise et des partenaires institutionnels externes, dont les missions sont complémentaires.

☞ **AU NIVEAU DE L'ENTREPRISE :** L'organisme employeur organise et finance la médecine du travail ; assume la responsabilité de la prévention en collaboration avec trois acteurs complémentaires :

- **Service de médecine du travail :** surveillance médicale des travailleurs, surveillance des conditions de travail, conseil et alerte.
- **Structures d'hygiène et de sécurité / CPHS :** identification des dangers, analyse des risques et participation à la prévention collective.
- **Travailleurs et leurs représentants :** participation à la prévention, signalement des situations dangereuses et dialogue social.

☞ **PARTENAIRES INSTITUTIONNELS EXTERNES**

| Organisme | Rôle principal |
|---|---|
| **Inspection du travail** | Contrôle de l'application de la législation du travail |
| **CNAS** | Assurance des accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP), actions de prévention |
| **INPRP** | Appui technique et actions de prévention des risques professionnels |
| **Structures sanitaires** | Soins, consultations spécialisées et examens complémentaires |

**À MÉMORISER :** Employeur = organise et prévient ; médecin du travail = surveille, conseille et alerte ; inspection du travail = contrôle ; CNAS = assure les AT/MP ; INPRP = contribue à la prévention.

**POINT IMPORTANT :** Cette organisation traduit une complémentarité des missions et non une subordination professionnelle du médecin du travail aux autres acteurs. Son indépendance médicale et le secret professionnel doivent être préservés. [4,7–10]

## 8. Organisation de la médecine du travail en Algérie

*La loi n° 88-07 et le décret exécutif n° 93-120* définissent les modalités d'organisation de la médecine du travail. La logique réglementaire est d'assurer une couverture effective des travailleurs, soit par un service organisé par l'employeur, soit par des dispositifs inter-organismes ou conventionnels dans les conditions prévues [4,10,12].

Le décret exécutif n° 93-120 utilise certaines dénominations liées à l'organisation sanitaire de l'époque. Lorsqu'on enseigne aujourd'hui, il faut conserver le sens juridique du texte tout en tenant compte des mises à jour plus récentes, notamment l'arrêté de 2025 qui mentionne explicitement les services inter-organismes, les services autonomes et les structures privées de santé spécialisées en médecine du travail [15].

## 9. Normes des services de médecine du travail — actualisation 2025

L'arrêté du 11 mars 2025 fixe les normes actuelles en moyens humains, locaux et équipements [15]. Cet arrêté abroge l'ancien arrêté de 2001 qui fixait les normes de moyens humains, locaux et équipements.

### 9.1. Moyens humains

Pour les services relevant d'un établissement public de santé, il prévoit au minimum *deux médecins du travail à temps plein, un infirmier, un secrétaire médical, un hygiéniste, un psychologue clinicien et un biologiste* [15].

**CHIFFRES CLÉS :** • 1 médecin du travail à temps plein pour 1 730 travailleurs fortement exposés

• 1 médecin du travail à temps plein pour 2 595 travailleurs moyennement ou peu exposés.

Le même arrêté précise également les effectifs infirmiers et le secrétariat selon les catégories de travailleurs.

### 9.2. Locaux et équipements

Le service doit disposer de locaux adaptés : cabinet médical, salle de soins, salle d'investigations complémentaires, secrétariat, salle d'attente, archives, sanitaires et salle de réunion. L'annexe fixe le cabinet médical à 16 m² et impose notamment des conditions d'accessibilité, d'isolation phonique, d'éclairage et d'aération [15].

L'équipement comprend le matériel d'examen clinique, les explorations fonctionnelles adaptées, le matériel de laboratoire courant et des appareils de mesure en milieu de travail selon les situations, notamment sonomètre et luxmètre [15].

## 10. Missions de la médecine du travail

*L'article 12 de la loi n° 88-07* concentre les finalités de la discipline [4]. Il faut en comprendre la logique plutôt que d'apprendre une liste isolée.

| 1- PROMOUVOIR | 2- PRÉVENIR | 3- IDENTIFIER | 4- ADAPTER | 5- MAINTENIR | 6- ÉVALUER |
|---|---|---|---|---|---|

Concrètement, la médecine du travail cherche à *1- promouvoir et maintenir la santé, 2- prévenir les AT/MP, 3- identifier les facteurs de risque, 4- adapter le travail à l'homme, 5- maintenir le travailleur dans un emploi compatible avec ses aptitudes, 6- évaluer l'état de santé et organiser certaines activités curatives accessoires.* Elle contribue également à la sauvegarde de l'environnement par rapport à l'homme et à la nature [4].

**MNÉMOTECHNIQUE :** P-P-I-A-M-E : Promouvoir • Prévenir • Identifier • Adapter • Maintenir • Évaluer.

## 11. Rôle du médecin du travail

Le médecin du travail est un médecin de prévention, mais il reste un médecin à part entière : il doit conserver son indépendance professionnelle et respecter le secret médical. Le Code de déontologie médicale algérien est le décret exécutif n° 92-276 du 6 juillet 1992 [9].

Il n'est pas chargé de gérer les ressources humaines, de décider des salaires ou de contrôler le bien-fondé des arrêts du travail prescrits par un autre médecin. Le décret n° 93-120 précise explicitement qu'il n'est pas habilité à vérifier le bien-fondé des absences pour maladie ou accident [10].

## 12. Les trois axes de l'action du médecin du travail

Pour mémoriser l'ensemble du cours, retenir le triptyque M–T–C :

**M — MÉDICAL :** Surveillance de l'état de santé : visites médicales (VE, VP, VS, VR), examens complémentaires, dépistage des MP/MCP/MDO, …, aptitude au poste du travail.

**T — TERRAIN :** Surveillance des conditions de travail : visite des lieux, étude de poste, identification des risques, métrologie.

**C — CONSEIL :** Conseil à l'employeur et information des travailleurs : prévention, adaptation, hygiène, formation, alerte.

Ces trois axes sont indissociables. Une décision d'aptitude sans connaissance du poste est fragile ; une visite de terrain sans traduction préventive est incomplète.

# PARTIE III — SUIVRE LE TRAVAILLEUR
Visites médicales, surveillance particulière, aptitude, dossier médical et secret

## 13. Surveillance médicale des travailleurs

Le décret exécutif n° 93-120 organise la surveillance médicale autour d'une séquence très facile à mémoriser : articles 13 à 19 [10].

> **ARTICLES 13 → 19 :** • 13 Embauche • 14 Reconversion • 15 Périodique • 16 Surveillance particulière • 17 Reprise • 18 Spontanée • 19 Examens complémentaires.

### 13.1. Visite d'embauche

Elle comporte un examen clinique complet et les examens paracliniques appropriés au risque. Elle vise notamment à apprécier l'aptitude au poste envisagé, rechercher les adaptations possibles et, si nécessaire, demander un nouvel examen ou l'avis d'un spécialiste d'organe (Pneumo, Dermato,ORL , Psychiatre… [10].

### 13.2. Visite périodique

Tous les travailleurs doivent bénéficier d'un examen périodique au moins une fois par an, afin de s'assurer du maintien de leur aptitude au poste [10]. Le contenu n'est pas un « bilan standard » : il doit être orienté par les expositions et les organes cibles.

### 13.3. Visite de reprise

Elle a lieu après *une maladie professionnelle ou un accident du travail, après un congé de maternité, après une absence d'au moins 21 jours pour maladie ou accident non professionnel, ou en cas d'absences répétées pour maladie non professionnelle* [10].

### 13.4. Visite spontanée et reconversion

Le travailleur peut demander une visite spontanée [10]. Toute reconversion de poste impose une nouvelle visite destinée à apprécier l'aptitude au poste envisagé [10].

## 14. Surveillance médicale particulière

Certaines catégories nécessitent un suivi renforcé. L'article 16 du décret n° 93-120 vise notamment les travailleurs particulièrement exposés, *les postes à responsabilité particulière de sécurité, les moins de 18 ans, les plus de 55 ans, le personnel de restauration, les personnes handicapées ou atteintes de maladie chronique, les femmes enceintes et les mères d'un enfant de moins de deux ans* [10].

> **PÉRIODICITÉ :** Règle générale : ≥ 1 fois/an • catégories de l'article 16 : ≥ 2 fois/an • travaux fortement exposés de l'arrêté du 9 juin 1997 : au moins semestriel avec examens adaptés [10,13].

Il ne faut pas additionner mécaniquement « visite annuelle + visite semestrielle » pour fabriquer trois visites par an : le texte fixe des périodicités minimales selon la catégorie.

## 15. Aptitude médicale au travail

L'aptitude répond à une question professionnelle : « L'état de santé est-il compatible avec les exigences et les risques de ce poste ? » Ce n'est pas un certificat d'absence de maladie.

| ÉTAT DE SANTÉ | EXIGENCES DU POSTE | RISQUES | COMPATIBILITÉ | ADAPTATION |
|---|---|---|---|---|

Un travailleur peut présenter une maladie chronique et rester compatible avec son poste. À l'inverse, une situation apparemment bénigne peut devenir importante si le poste comporte une contrainte particulière de sécurité.

### 15.1. Adapter avant d'exclure

Le décret permet au médecin, dès l'embauche, de proposer des adaptations et de rechercher les postes qui conviendraient le mieux au travailleur [10]. En pratique, on cherche d'abord à modifier une tâche, éviter une exposition ciblée ou aménager l'organisation avant d'envisager une autre affectation.

> **FORMULE À RETENIR : APTITUDE = SANTÉ × POSTE × RISQUE**. Le diagnostic seul ne suffit jamais.

### 15.2. Avis du médecin et responsabilité de l'employeur

L'employeur doit prendre en considération les avis du médecin du travail dans les domaines prévus par le décret, notamment les mutations liées à une altération de santé et l'amélioration des conditions de travail. Si certains avis ne sont pas pris en considération, le décret prévoit une saisine de l'inspecteur du travail [10].

### 15.3. Exemples pratiques d'appréciation de l'aptitude médicale

L'aptitude médicale s'apprécie pour un poste de travail déterminé, en tenant compte de l'état de santé du travailleur, des exigences du poste et des risques professionnels.

| Situation médico-professionnelle | Orientation possible du médecin du travail |
|---|---|
| **Employé administratif présentant une hypertension artérielle bien contrôlée** | Compatibilité avec le poste, sous réserve de l'évaluation individuelle |
| **Manutentionnaire présentant des lombalgies récurrentes** | Proposition d'aménagement : réduction des manutentions contraignantes, aides mécaniques et adaptation des tâches |
| **Agent de nettoyage présentant un asthme aggravé par certains produits** | Évaluation des expositions, éviction de l'agent en cause, substitution du produit ou adaptation du poste |
| **Travailleur affecté en hauteur présentant des vertiges récents** | Restriction provisoire des tâches en hauteur, bilan médical et réévaluation de la compatibilité avec le poste |

> **DÉMARCHE DÉCISIONNELLE :** État de santé → étude du poste réel → identification des risques → appréciation de la compatibilité → recherche d'aménagements → formulation de l'avis médical → suivi et réévaluation.

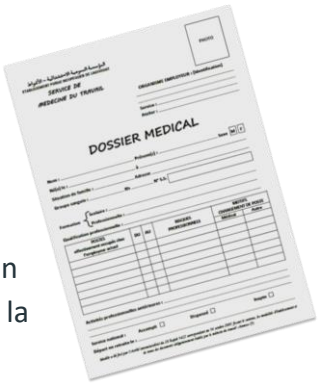
> **PRINCIPE FONDAMENTAL :** Une maladie ne signifie pas automatiquement une inaptitude. Le médecin du travail recherche prioritairement les possibilités d'adaptation du poste et de maintien en emploi.

> **SECRET MÉDICAL :** L'avis communiqué à l'employeur ne doit pas révéler le diagnostic. Il comporte les conclusions professionnelles et, si nécessaire, les restrictions fonctionnelles ou recommandations d'aménagement, conformément aux textes applicables.

> **PIÈGE FRÉQUENT :** Ne jamais conclure à une inaptitude sur le seul diagnostic médical, sans analyser les exigences et les risques du poste de travail. [9,10,14]

## 16. Dossier médical en santé au travail et secret médical

### 16.1. Dossier médical individuel




Le dossier médical individuel est constitué lors de la visite d'embauche et complété après chaque examen ultérieur [14]. Il assure la mémoire médico-professionnelle : postes occupés, expositions, données cliniques, examens complémentaires et avis médicaux utiles.

La règle générale de conservation est de dix ans après la mise à la retraite. Si un risque professionnel a un délai réglementaire de prise en charge supérieur, la conservation doit s'y conformer [14].

### 16.2. Fiche de visite médicale

La fiche de visite médicale individuelle est différente du dossier médical. Elle précise la conclusion d'aptitude destinée à l'employeur et doit être renouvelée lors des visites périodiques et de reprise [14].

> **DIFFÉRENCE ESSENTIELLE :** DMST = raisons médicales, confidentielles. Fiche de visite = conclusion professionnelle nécessaire à l'employeur.

**FICHE DE VISITE MÉDICALE INDIVIDUELLE**

**NOM** …… **PRENOM** ……

**DATE DE NAISSANCE** ……

**ADRESSE** ……

**ORGANISME EMPLOYEUR** ……

**PROFESSION** ……

**POSTE DE TRAVAIL** ……

**DATE DE LA VISITE MÉDICALE** ……

**CONCLUSION MEDICALE** ……

**SERVICE DE MEDECINE DU TRAVAIL** ……

**LE MEDECIN DU TRAVAIL** ……

*SIGNATURE / CACHET*

*NB-A conserver par l'employeur.*

### 16.3. Secret médical

Le médecin et ses auxiliaires sont tenus au secret professionnel. L'employeur n'a pas accès au diagnostic, aux antécédents, aux résultats biologiques ni au contenu du dossier médical. Il reçoit seulement les éléments fonctionnels nécessaires à la gestion du poste, dans les limites prévues par les textes [5,9,14].

# PARTIE IV — AGIR SUR LE TERRAIN ET PRÉVENIR

Conditions de travail, conseil, vaccination, activités complémentaires, prévention et coordination

## 17. Surveillance des conditions de travail

Le médecin du travail doit connaître le milieu réel dans lequel les salariés travaillent. Le décret prévoit le libre accès aux locaux de travail et un temps consacré à la surveillance du milieu selon la nature des risques, les effectifs et le mode d'organisation [10].

### 17.1. Visite des lieux de travail

La visite permet d'observer le procédé, les tâches, les produits, les machines, les ambiances, l'organisation et les protections. Elle confronte le travail prescrit au travail réel.

### 17.2. Étude de poste

L'article 23 du décret n° 93-120 organise l'analyse des postes autour de trois dimensions : *hygiène du travail, physiologie du travail et psychologie du travail* [10]. Ce cadre est particulièrement utile lorsqu'une pathologie pourrait être liée au travail ou lorsqu'un aménagement est envisagé.

### 17.3. Métrologie

Certaines nuisances doivent être objectivées par une mesure : bruit, éclairage, ambiance thermique, vibrations ou agents chimiques selon le contexte. La métrologie n'a de sens que si la mesure représente l'exposition réelle du poste.

> **DÉMARCHE TERRAIN :** VISITER → OBSERVER → IDENTIFIER LE DANGER → REPÉRER LES EXPOSÉS → ANALYSER LE POSTE → MESURER SI NÉCESSAIRE → PRÉVENIR.

## 18. Rôle de conseiller

L'article 22 du décret n° 93-120 qualifie le médecin du travail de conseiller de l'organisme employeur pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, l'hygiène, l'adaptation des postes, la protection contre les nuisances et l'éducation du personnel [10]. Dans son action quotidienne, il informe également les travailleurs sur leurs risques et moyens de prévention.

- amélioration des conditions de travail et de l'hygiène ;
- prévention des accidents du travail et maladies professionnelles ;
- choix et bon usage des protections ;
- adaptation des postes, techniques et rythmes de travail ;
- information, sensibilisation et formation ;
- participation aux travaux des organes d'hygiène et de sécurité ;
- signalement d'un risque sanitaire et formulation de recommandations.

> **À MÉMORISER :** Le médecin conseille et alerte ; il ne devient pas le décideur technique ou administratif à la place de l'employeur.

## 19. Vaccination en milieu professionnel

La vaccination est une prévention médicale complémentaire du risque biologique. Elle s'inscrit toujours dans une analyse du poste et ne remplace ni les mesures d'hygiène, ni la prévention collective, ni les EPI [19–21].

Les textes algériens encadrent notamment la vaccination DT en milieu de travail et la vaccination contre l'hépatite B pour les personnes exposées concernées dans les structures de soins ou de prévention [19–21]. Les autres indications dépendent du risque professionnel et seront détaillées dans le cours sur les risques biologiques.

> **MESSAGE SIMPLE :** VACCINATION + HYGIÈNE + MESURES COLLECTIVES + EPI + CONDUITE À TENIR EN CAS D'EXPOSITION = stratégie complète.

## 20. Activités curatives accessoires

L'activité curative reste accessoire. Le décret n° 93-120 prévoit notamment les soins d'urgence aux travailleurs victimes d'accident ou de malaise, le suivi de certains traitements ambulatoires et la prise en charge des MP/MCP en liaison avec les autres structures de santé [10].

Le service de médecine du travail ne doit donc pas devenir une consultation de médecine générale d'entreprise. Son activité curative doit rester cohérente avec sa mission préventive.

> **RÉFLEXE :** Urgence : évaluer → premiers gestes → stabiliser → orienter/évacuer. Le lien avec le travail est analysé ensuite, une fois la priorité vitale assurée.

## 21. Activités médico-administratives

### 21.1. Documents obligatoires

L'arrêté du 16 octobre 2001 relatif aux documents demeure une référence essentielle. Il prévoit sept (07) documents : dossier médical, fiche de visite, registre d'activité et de visites, registre des postes exposés, registre des vaccinations, registre des maladies professionnelles et registre des visites d'ateliers [14].

Ces documents ont une fonction de traçabilité : suivre le travailleur, reconstruire les expositions, prouver l'activité du service et produire une vision collective des risques.

### 21.2. Rapport annuel — actualisation 2025

Le rapport annuel a été actualisé par l'arrêté interministériel du 20 mars 2025, publié au JO n° 27 du 4 mai 2025 [16]. Il remplace le rapport type de 2001.

> **DÉLAIS ACTUELS :** Le médecin établit le rapport chaque année et le présente à l'employeur au plus tard à la fin du 1er mois suivant l'année concernée. Les services créés au sein des organismes employeurs transmettent une copie au service de médecine du travail de l'EPSP compétent dans le même délai. L'employeur transmet ensuite un exemplaire, avec les observations des représentants des travailleurs, à l'inspection du travail dans le mois suivant sa réception [16].

## 22. Prévention en santé au travail

### 22.1. Quand agit-on ?

| Niveau | But | Exemple |
|---|---|---|
| **P. Primaire** | Empêcher le dommage. | Substitution d'un solvant dangereux. |
| **P. Secondaire** | Dépister précocement. | Audiométrie chez un salarié exposé au bruit. |
| **P. Tertiaire** | Limiter les conséquences et maintenir en emploi. | Aménagement après pathologie installée. |

### 22.2. Comment agit-on ?

La prévention collective agit sur la situation de travail ; la prévention individuelle protège le travailleur contre le risque résiduel ; la prévention médicale surveille, dépiste, vaccine, conseille et contribue à l'adaptation.

**SUPPRIMER** | **SUBSTITUER / RÉDUIRE** | **PROTÉGER COLLECTIVEMENT** | **ORGANISER** | **FORMER** | **EPI** | **SURVEILLER**

**NB ! :** La surveillance médicale n'est pas une protection contre l'exposition. Une audiométrie ne réduit pas le bruit ; une spirométrie ne réduit pas les poussières.

## 23. Coordination et liaisons du médecin du travail

Le médecin du travail est un acteur d'interface. À l'intérieur de l'entreprise, il échange avec la direction, les ressources humaines, l'hygiène-sécurité, la CPHS, les travailleurs et leurs représentants. À l'extérieur, il peut être en relation avec la CNAS, l'inspection du travail, les structures sanitaires et les organismes de prévention.

**RÈGLE DE COMMUNICATION :** Coordonner ne signifie jamais ouvrir le dossier médical. Les échanges doivent porter sur les informations nécessaires à la prévention, au poste et à l'organisation du suivi.

# PARTIE V — RAISONNER ET RÉVISER
Algorithme pratique, synthèse

## 24. Application pratique : raisonnement devant une situation de santé au travail

Le raisonnement de santé au travail doit être reproductible. Devant n'importe quel patient, l'étudiant peut utiliser l'algorithme des 9 questions.

1. Quel est le poste exact ?
2. Quelles sont les tâches réellement effectuées ?
3. À quels dangers et expositions le travailleur est-il soumis ?
4. Dans quelles conditions : durée, fréquence, voies d'exposition, protections ?
5. Quel est l'état de santé et quels organes cibles faut-il examiner ?
6. Existe-t-il une compatibilité entre la santé du travailleur et les exigences du poste du travail ?
7. Quelles mesures de prévention doivent être proposées ?
8. Un aménagement ou une autre affectation est-il nécessaire ?
9. Quelles informations peuvent être communiquées sans violer le secret médical ?

**CURRICULUM LABORIS :** L'anamnèse professionnelle doit reconstituer la carrière : entreprises, métiers, postes, tâches, produits, expositions, protections, incidents et chronologie des symptômes.

## 25. L'essentiel en une page

**1. DÉFINITION :** Santé au travail = champ large. Médecine du travail = composante médicale de prévention.

**2. TEXTE PIVOT :** Loi 88-07 : médecine du travail préventive essentiellement, curative accessoirement ; obligation et financement par l'employeur.

**3. ORGANISATION :** Décret 93-120 : articles 13–19 = surveillance médicale ; 21–26 = terrain et conseil ; 27 = curatif accessoire ; 29 = documents.

**4. ACTUALISATION 2025 :** 11 mars : normes des services. 20 mars : nouveau rapport type annuel.

**5. LES 3 AXES :** M–T–C = **M**édical • **T**errain • **C**onseil.

**6. VISITES :** V. Embauche • V. périodique • V. reprise • V. spontanée • reconversion + surveillance particulière.

**7. APTITUDE :** Santé × Poste × Risque. Maladie ≠ inaptitude automatique.

**8. SECRET :** DMST confidentiel ; employeur = conclusion professionnelle, pas le diagnostic.

**9. PRÉVENTION :** Agir à la source avant de compter sur les EPI ou la surveillance médicale.

# PARTIE VI — RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Sources officielles et institutionnelles utilisées pour ce cours

## 26. Références bibliographiques

**Sources internationales et institutionnelles**

[1] Organisation mondiale de la Santé (OMS). *Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé*. Adoptée à New York le 22 juillet 1946.

[2] World Health Organization. *Healthy workplaces: a model for action: for employers, workers, policymakers and practitioners*. Geneva: WHO; 2010. ISBN: 978-92-4-159931-3.

[3] Organisation internationale du Travail (OIT). *Convention n° 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs*, adoptée le 22 juin 1981 à Genève. Ratifiée par l'Algérie le 6 juin 2006.

**Législation et réglementation algériennes**

[4] Loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail. *Journal officiel de la République algérienne* n° 04 du 27 janvier 1988, p. 84-89.

[5] Loi n° 18-11 du 2 juillet 2018 relative à la santé, modifiée et complétée. *Journal officiel* n° 46 du 29 juillet 2018, p. 3-38.

[6] Loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, modifiée et complétée. *Journal officiel* n° 17 du 25 avril 1990, p. 488 et suivantes.

[7] Loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l'inspection du travail. *Journal officiel* n° 06 du 7 février 1990, p. 206 et suivantes.

[8] Loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, modifiée et complétée. *Journal officiel* n° 28 du 5 juillet 1983, p. 1210 et suivantes.

[9] Décret exécutif n° 92-276 du 6 juillet 1992 portant Code de déontologie médicale. *Journal officiel* n° 52 du 8 juillet 1992, p. 1160 et suivantes.

[10] Décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l'organisation de la médecine du travail. *Journal officiel* n° 33 du 19 mai 1993, p. 7-11.

[11] Décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d'hygiène et de sécurité en milieu de travail. *Journal officiel* n° 04 du 23 janvier 1991, p. 63-70.

[12] Arrêté interministériel du 2 avril 1995 fixant la convention-type relative à la médecine du travail. *Journal officiel* n° 30 du 15 mai 1996, p. 17-19.

[13] Arrêté interministériel du 9 juin 1997 fixant la liste des travaux où les travailleurs sont fortement exposés aux risques professionnels. *Journal officiel* n° 75 du 12 novembre 1997, p. 30 et suivantes.

[14] Arrêté interministériel du 16 octobre 2001 fixant le contenu, les modalités d'établissement et de tenue des documents obligatoirement établis par le médecin du travail. *Journal officiel* n° 21 du 27 mars 2002, p. 4-12.

[15] Ministère de la Santé. Arrêté du 11 mars 2025 fixant les normes en matière de moyens humains, de locaux et d'équipements des services de médecine du travail. *Journal officiel* n° 22 du 14 avril 2025, p. 22-23.

[16] Arrêté interministériel du 20 mars 2025 fixant le rapport type du médecin du travail. *Journal officiel* n° 27 du 4 mai 2025, p. 18-24.

[17] Décret exécutif n° 96-98 du 6 mars 1996 déterminant la liste et le contenu des livres et registres spéciaux obligatoires pour les employeurs. *Journal officiel* n° 17 du 13 mars 1996, p. 11-13.

[18] Décret exécutif n° 97-424 du 11 novembre 1997 fixant les conditions d'application du titre V de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relatif à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. *Journal officiel* n° 75 du 12 novembre 1997, p. 12-13.

**Vaccination en milieu professionnel**

[19] Arrêté du 25 avril 2000 relatif à la vaccination contre l'hépatite virale B. *Journal officiel* n° 39 du 4 juillet 2000.

[20] Ministère de la Santé et de la Population. Direction de la prévention. *Instruction n° 61 du 25 janvier 2000 relative à la vaccination en milieu de travail*.

[21] Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Direction de la prévention. *Instruction ministérielle n° 932/MSPRH/DP du 10 août 2002 relative au remplacement de la vaccination antitétanique (VAT) par la vaccination antidiphtérique-antitétanique (DT)*.

**Références scientifiques**

[22] World Health Organization; International Labour Organization. *WHO/ILO joint estimates of the work-related burden of disease and injury, 2000–2016: global monitoring report*. Geneva: WHO; 2021. ISBN: 978-92-4-003494-5.

[23] Franco G, Franco F. Bernardino Ramazzini: the father of occupational medicine. *American Journal of Public Health*. 2001;91(9):1382. doi:10.2105/AJPH.91.9.1382.

**Références complémentaires — organisation et classification des entreprises**

[24] Loi n° 17-02 du 10 janvier 2017 portant loi d'orientation sur le développement de la petite et moyenne entreprise (PME). *Journal officiel* n° 02 du 11 janvier 2017, p. 3-7.

[25] Ordonnance n° 74-65 du 10 juin 1974 portant création de l'Organisme national inter-entreprises de la médecine du travail (ONIMET). *Journal officiel* n° 49 du 18 juin 1974, p. 551 et suivantes.

[26] Décret exécutif n° 2000-253 du 23 août 2000 portant création, organisation et fonctionnement de l'Institut national de la prévention des risques professionnels (INPRP). *Journal officiel* n° 53 du 27 août 2000.